



TERZA ETÀ
ATTIVA PRO · BONUS 1



+100 ESERCIZI MOBILITÀ RIDOTTA *per la Terza Età*



Bonus 1 di 4 · Terza Età Attiva Pro · edizione 2026



MOVIMENTO
BENESSERE
TERZA ETÀ ATTIVA



TERZA ETÀ ATTIVA PRO · Bonus 1 · 2026





INDICE · BONUS 1

1

Fase A · In Letto

pp. 4-13

2

Fase B · In Carrozzina

pp. 14-25

3

Fase C · Con Emiparesi

pp. 26-32

4

Fase D · Adattamenti Generali *pp. 33-38*





KIT GERIATRIA
Strumenti pratici per terapeuti

Nessuno resta fuori dalla seduta

*Il bonus per pazienti in sedia a rotelle,
allettati, con emiparesi.*

Il kit principale assume che il paziente possa muoversi liberamente. Ma la realtà del lavoro geriatrico è diversa: metà dei tuoi pazienti sono in carrozzina, un terzo ha avuto un ictus, alcuni sono allettati per settimane.

Questo bonus è la risposta operativa:
100 esercizi illustrati organizzati in
4 fasi di mobilità decrescente.

Ogni esercizio con i suoi **warning**,
i suoi adattamenti, i suoi criteri
di sicurezza.



Respirazione Diaframmatica in Letto

Attivazione respiratoria per allettati
• 8 cicli • supino



INSPIRA
l'addome si solleva



ESPIRA
l'addome si abbassa



OBIETTIVO:
Migliorare
ventilazione e
ossigenazione



MATERIALI:
Cuscino sotto
ginocchia



WARNING:
Se dispnea,
mantenere testa
più alta



ESECUZIONE

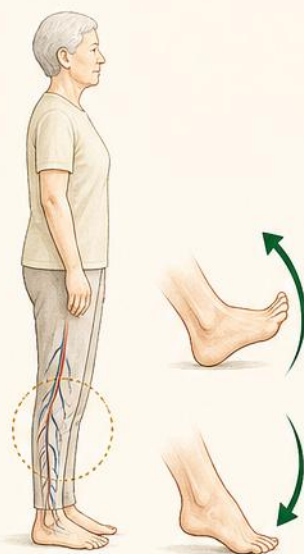
- 1) 1) Supino con ginocchia flesse su cuscino
- 2) 2) Una mano su petto una su addome
- 3) 3) Inspirare dal naso 4 sec facendo salire solo l'addome
- 4) 4) Espirare 6 sec facendo scendere
- 5) 5) 8 cicli



**TERZA ETÀ
ATTIVA
PRO**

Attivazione Circolatoria Caviglia Letto

Prevenzione TVP • 3×20 per piede • supino

**OBIETTIVO:**

Prevenire
trombosi venosa
profonda

**MATERIALI:**

Cuscino sotto
polpacci
opzionale

**WARNING:**

Se dolore
polpaccio segnalare
per sospetto TVP



ESECUZIONE

1

1) **Supino** con gambe estese.

**2**

2) Flesso-estensione
caviglia (dita su/giù)
20 volte per piede.

**3**

3) **3 serie** a distanza
di **2 ore** durante il giorno.



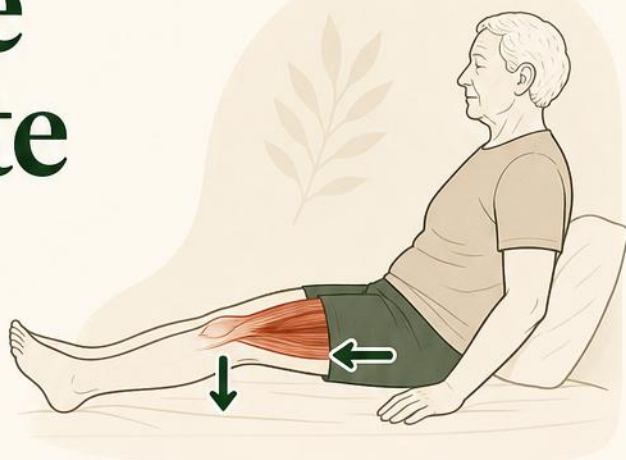
Ripeti regolarmente
durante il giorno

TERZA ETÀ
ATTIVA
PRO



Attivazione Quadricipite Isometrica

Rinforzo quadricipite senza movimento ·
3×10 per gamba · supino

**OBIETTIVO:**

Prevenire atrofia
da immobilizzazione

**MATERIALI:**

Nessuno

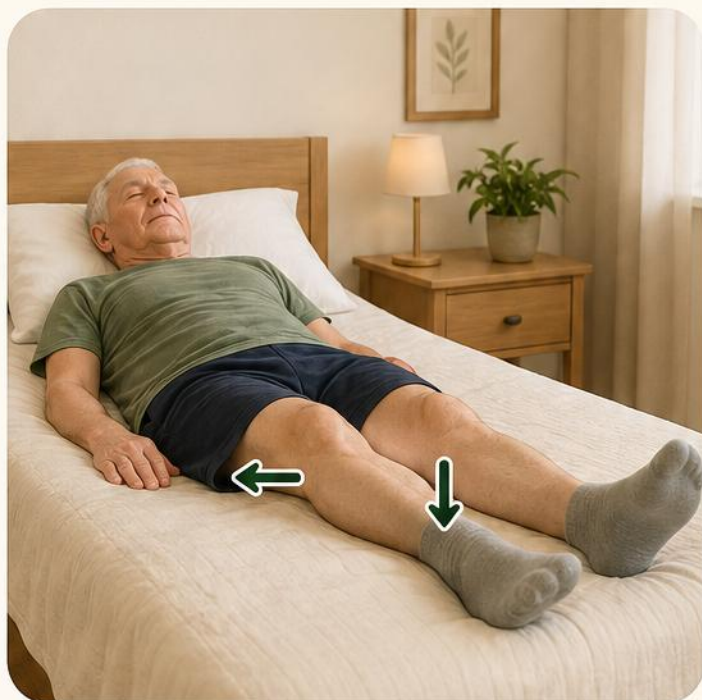
**WARNING:**

Fermare al primo segno
di dolore o instabilità



ESECUZIONE

- 1) Supino con gamba estesa
- 2) Spingere il retro del ginocchio verso il letto contraendo il quadricipite
- 3) Tenere 5 sec
- 4) Rilasciare 5 sec
- 5) 10× per gamba
- 6) 3 serie giorno



TERZA ETÀ
ATTIVA
PRO

Stringere Glutei da Sdraiato

Rinforzo glutei allettati · 3 × 10 · supino



OBIETTIVO:

Mantenere tonicità
glutei e prevenire
piaghe da decubito



MATERIALI:

Nessuno



WARNING:

Utile anche per
prevenire piaghe da
decubito sacrali

ESECUZIONE

1) Supino con ginocchia flesse



2) Stringere i glutei come
chiudendo una noce



3) Tenere 5 sec



4) Rilasciare



5) 10 ×



6) 3 serie giorno



Ripetere l'esercizio
3 volte al giorno



TERZA ETÀ
ATTIVA

PRO

Ponte Semplice a Letto

Rinforzo glutei + core allettato • 2×8 • supino

**OBIETTIVO:**

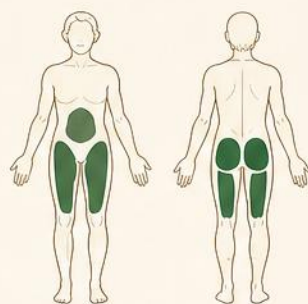
Rinforzo posteriore
e mobilizzazione
bacino

**MATERIALI:**

Cuscino sotto
piedi opzionale

**WARNING:**

Se dolore lombare,
ridurre altezza
sollevamento



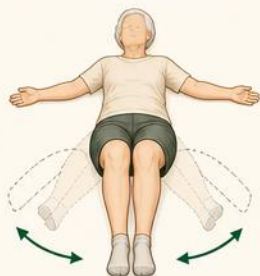
ESECUZIONE

- 1) Supino con ginocchia flesse e piedi appoggiati
- 2) Alzare il bacino di 5-10 cm sollevando i glutei
- 3) Tenere 2 sec
- 4) Abbassare controllando
- 5) 8×
- 6) 2 serie



Rotazione Tronco Passiva a Letto

Mobilizzazione tronco allettato · 2×5 per lato · supino



OBIETTIVO:
Prevenire rigidità
dorso-lombare



MATERIALI:
Cuscino per
supporto



WARNING:
Movimento lento,
no rimbalzi



ESECUZIONE

- 1) 1) Supino con ginocchia flesse
- 2) 2) Lasciare cadere lentamente le ginocchia unite verso destra fino a sfiorare il letto
- 3) 3) 5 sec
- 4) 4) Tornare al centro
- 5) 5) Sinistra
- 6) 6) 5× per lato



1) Posizione iniziale



2) Verso destra



5) Verso sinistra



CONSIGLIO:
Utilizzare un cuscino sotto le ginocchia se serve per maggiore comfort e per facilitare il movimento.



TERZA ETÀ
ATTIVA PRO

Flessione Braccio a Letto

*Mantenimento spalla-gomito ·
3×10 per braccio · supino*



OBIETTIVO:

Prevenire rigidità
arti superiori



MATERIALI:

Nessuno



WARNING:

Se dolore spalla,
ridurre range



ESECUZIONE

- 1) Supino con braccia lungo il corpo
- 2) Alzare un braccio disteso portandolo dietro la testa
- 3) Riportare al fianco
- 4) 10× per braccio
- 5) 3 serie durante il giorno



Apri-Chiudi Mano

Attivazione mani + circolazione · 3×15 per mano · supino



OBIETTIVO:
Mantenere forza
mano allettato



MATERIALI:
Palla morbida
piccola opzionale



WARNING:
Fermare al primo segno
di dolore o instabilità

ESECUZIONE

1 1) Braccia lungo il corpo



2 2) Chiudere pugno con forza



3 3) Aprire mano ventaglio



4 4) 15× per mano

15×

5 3 serie giorno

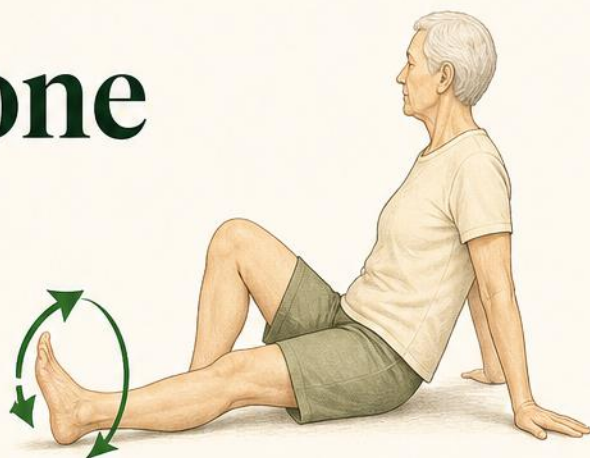


6 Con palla: stringere e rilasciare



Circonduzione Caviglia

*Mobilità caviglia + circolazione ·
2×10 per verso per piede*



OBIETTIVO:
Prevenire rigidità
caviglia



MATERIALI:
Nessuno



WARNING:
Fermare al primo segno
di dolore o instabilità



ESECUZIONE

- 1) Supino
- 2) Circonduzione caviglia in senso orario 10×
- 3) Antiorario 10×
- 4) Cambio piede
- 5) 2 serie al giorno





WARNING · BONUS 1 · MOBILITÀ RIDOTTA

Segnali di Piaghe da Decubito · Cosa Osservare



Prevenire piaghe in pazienti allettati · quotidiano



Zone da controllare 2 volte al giorno:
sacro · trocanteri · talloni · scapole ·
gomiti · orecchie.



Stadio 1 = arrossamento persistente
>30 min dopo scarico.

Se osservato: aumentare rotazioni (ogni 2h),
cuscini di scarico, avvisare medico/infermiere.



STADIO 2+ (vescica, ferita aperta):
fermare mobilizzazione della zona
e attivare protocollo piaghe.



REGOLA D'ORO:

**Non massaggiare mai una zona
arrossata — peggiora danno tissutale**

Spinta con Braccia dalla Carrozzina

Rinforzo arti superiori funzionale · 2×8



MUSCOLI
PRINCIPALI
COINVOLTI

- Tricipiti
- Deltoidi (anteriori)
- Gran pettorale
- Stabilizzatori della spalla e del core



OBIETTIVO:
Rinforzo per
autonomia in carrozzina



MATERIALI:
Carrozzina con
freni bloccati



WARNING:
Se difficoltà con arti
superiori, ridurre
altezza a 1 cm



ESECUZIONE

1) Seduto in carrozzina con freni



2) Mani sui braccioli



3) Spingere in basso alzando leggermente il sedere (2-3 cm)



4) Tenere 2 sec



5) Sedere lentamente



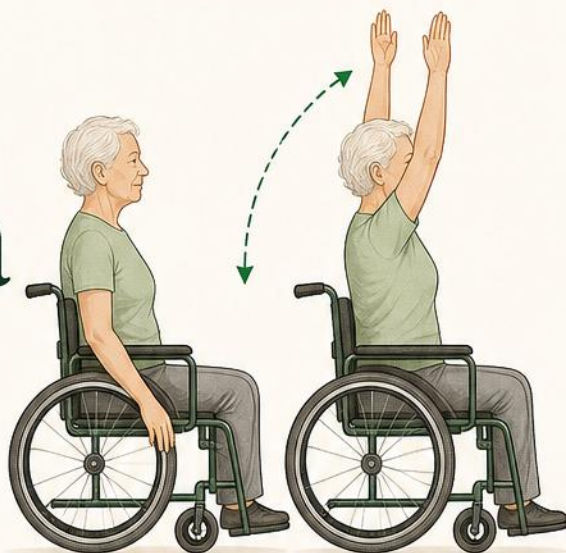
6) 8×

8×



Estensione Braccia Sopra Testa

Mobilità spalla in carrozzina · 2×10



OBIETTIVO:

Mantenere
mobilità completa
spalla



MATERIALI:

Nessuno o
pesetti 0.5 kg



WARNING:

Se dolore spalla,
ridurre range



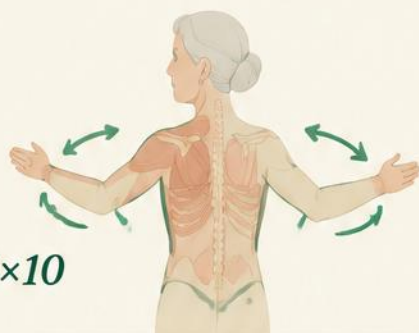
ESECUZIONE

- 1 Seduto in carrozzina
- 2 Alzare entrambe le braccia sopra la testa lentamente
- 3 Tornare
- 4 10×
- 5 2 serie
- 6 Con pesetti se il livello lo permette



Abbraccio Largo per Petto

Apertura toracica + mobilità scapolare · 2×10



OBIETTIVO:

Contrastare cifosi da postura seduta



MATERIALI:

Nessuno



WARNING:

Fermare al primo segno di dolore o instabilità.

ESECUZIONE

1 Seduto in carrozzina.



2 Braccia estese lateralmente all'altezza spalle (croce).



3 Portare braccia in avanti come per abbracciare.



4 Tornare in croce.



5 10x.



6 2 serie.



TERZA ETÀ ATTIVA PRO

Flessione Gomito con Pesetto

Rinforzo bicipite in carrozzina • 2×10 per braccio



OBIETTIVO:

Rinforzo per autonomia nelle attività quotidiane (mangiare,



MATERIALI:

Pesetto 0.5-1 kg o bottiglia acqua



WARNING:

Se non hai pesetti, usare bottiglia d'acqua da 500 ml

1



2



3



4



ESECUZIONE

- 1 Seduto in carrozzina;
- 2 Braccio lungo il corpo con pesetto;
- 3 Flettere gomito portando pesetto verso spalla;
- 4 Estendere lentamente;
- 5 10× per braccio;
- 6 2 serie.



TERZA ETÀ ATTIVA
— PRO —



Estensione Gomito Dietro

*Rinforzo tricipite in carrozzina ·
2×10 per braccio*

**OBIETTIVO:**

Rinforzo tricipite
per spinta e
stabilizzazione

**MATERIALI:**

Pesetto 0.5 kg
opzionale

**WARNING:**

Fermare al primo
segno di dolore o
instabilità



ESECUZIONE

1

1) Seduto

2

2) Braccio flesso a 90° con gomito vicino al corpo

3

3) Estendere avambraccio dietro il corpo

4

4) Tornare a 90°

5

5) 10× per braccio

6

2 serie



Rotazione Tronco in Carrozzina

Mobilità colonna in seduta • 2×5 per lato

**OBIETTIVO:**

Mantenere
mobilità rotatoria
colonna

**MATERIALI:**

Nessuno

**WARNING:**

Fermare al primo
segno di dolore
o instabilità



ESECUZIONE

- 1) Seduto in carrozzina
- 2) Braccia incrociate al petto
- 3) Ruotare tronco a destra guardando dietro
- 4) Tenere 3 sec
- 5) Ritornare
- 6) Sinistra



Flesso-Estensione Collo

Mobilità cervicale in carrozzina • 2×8

**OBIETTIVO:**

Mantenere
mobilità cervicale

**MATERIALI:**

Nessuno

**WARNING:**

No estensione forte
indietro (rischio
arteria vertebrale)



ESECUZIONE

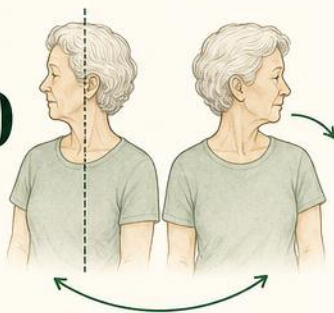
- 1) Seduto in carrozzina
- 2) Portare mento verso petto (flessione)
- 3) Sollevare mento verso il soffitto (estensione lieve)
- 4) 8×
- 5) 2 serie





Rotazione Collo

Mobilità cervicale rotatoria · 2×5 per lato

**OBIETTIVO:**

Mantenere
rotazione cervicale

**MATERIALI:**

Nessuno

**WARNING:**

Fermare al primo segno
di dolore o instabilità

ESECUZIONE

- 1) Seduto
- 2) Sguardo dritto avanti
- 3) Ruotare lentamente la testa a destra
fino a guardare sulla spalla
- 4) Tornare al centro
- 5) Sinistra
- 6) 5× per lato



Attivazione Piedi da Carrozzina

Prevenzione edemi arti inferiori · 3×15



OBIETTIVO:
Migliorare
circolazione
arti inferiori



MATERIALI:
Poggiapiedi
carrozzina



WARNING:
Fermare al primo
segno di dolore
o instabilità

ESECUZIONE

1.

1) Piedi appoggiati
sui poggiapiedi



2.

2) Sollevare punte 15×



3.

3) Sollevare talloni 15×



4.

4) Circonduzione caviglia
8× per verso per piede



5.

5) 3 serie durante il giorno

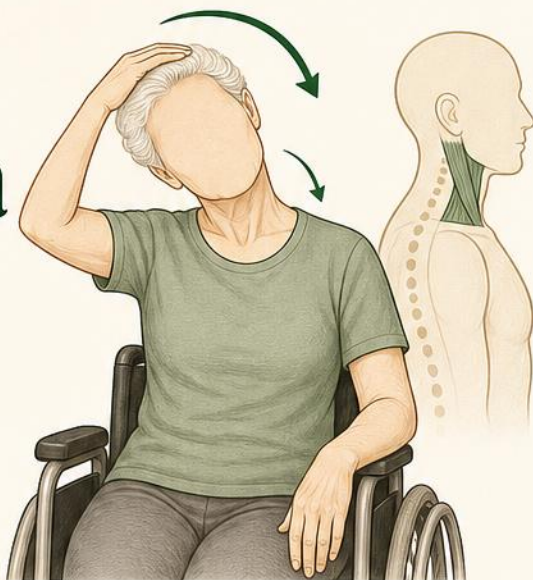


Distribuire le serie
nell'arco della giornata.



Stretching Collo Laterale in Carrozzina

*Rilasciare tensione cervicale ·
2×20 sec per lato*

**OBIETTIVO:**

Ridurre tensione da postura seduta prolungata

**MATERIALI:**

Nessuno

**WARNING:**

Fermare al primo segno di dolore o instabilità

— ESECUZIONE —

- 1) Seduto in carrozzina in postura corretta
- 2) Mano destra appoggia lieve sul lato sinistro della testa
- 3) Inclinare la testa a destra guidando dolcemente
- 4) 20 sec
- 5) Cambio lato
- 6) 2 serie



Auto-Massaggio Mani in Carrozzina

Rilassamento e attivazione mani · 3 min



OBIETTIVO:

Ridurre rigidità artrosica



MATERIALI:

Olio o crema opzionale



WARNING:

Fermare al primo
segno di dolore o instabilità



ESECUZIONE

1)



1) In carrozzina

2)



2) Massaggiare palmo mano destra
con pollice sinistro in circoli

3)



3) Ogni dito dalla base alla punta

4)



4) Trazione dolce di ogni dito

5)



5) 90 sec

6)



6) Cambio mano



Protocollo Trasferimento Carrozzina-Letto in Sicurezza

Trasferimento assistito · 5 min · caregiver



OBIETTIVO:

Trasferimenti sicuri per paziente e operatore



MATERIALI:

Freni carrozzina ·
cintura ergonomica ·
scarpe antiscivolo



PROCEDURA

- 1) Freni carrozzina bloccati
- 2) Cintura ergonomica al bacino paziente
- 3) Piedi paziente ben appoggiati
- 4) Operatore in posizione affondo davanti al paziente
- 4) 'Al 3, uno-due-tre' comunicare
- 6) Paziente si aiuta con spinta braccioli
- 7) Operatore afferra cintura (NON braccia)

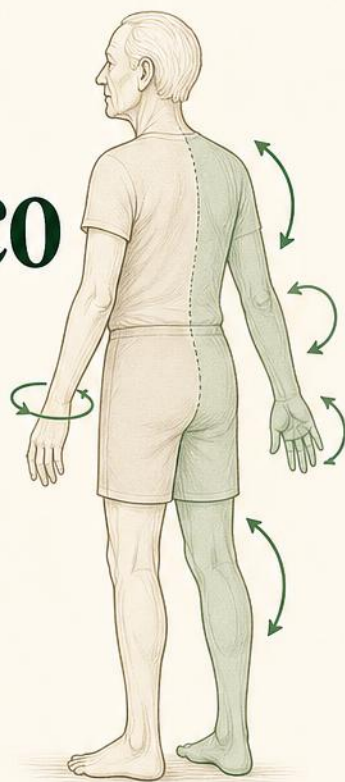


ATTENZIONE:

MAI sollevare tirando le braccia — rischio lussazione spalla ·
Se paziente pesante, 2 operatori o sollevatore meccanico

Attivazione Passiva Lato Plegico

*Mantenimento articularità lato plegico •
2×10 per articolazione*

**OBIETTIVO:**

Prevenire contratture e rigidità nel lato non attivo

**MATERIALI:**

Nessuno • assistenza caregiver

**WARNING:**

Movimenti dolci e lenti —
no forzare oltre resistenza



ESECUZIONE

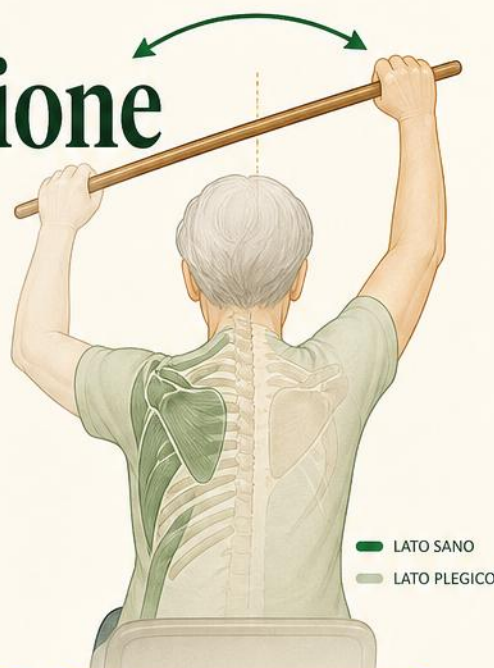
1. Caregiver mobilizza passivamente il lato plegico:
2. 1) **Spalla:** flesso-estensione 10×
3. 2) **Gomito:** flesso-estensione 10×
4. 3) **Polso:** circonduzione 10×
5. 4) **Dita:** apri-chiudi 10×
6. 5) **Anca:** flesso-estensione 10×
6. 6) **Ginocchio** 10×





Auto-Mobilizzazione Bimanuale

Coinvolgere lato sano per aiutare lato plegico · 2×10



OBIETTIVO:

Coinvolgere lato attivo per aiutare lato plegico



MATERIALI:

Bastone o asciugamano



WARNING:

Fermare al primo segno di dolore o instabilità

ESECUZIONE

- 1) Bastone tra le due mani con presa a estremità
- 2) Lato sano guida il movimento portando bastone sopra testa
- 3) Il lato plegico segue passivamente
- 4) 10×
- 5) 2 serie
- 6) **Alternative:** circonduzione, rotazione tronco



TERZA ETÀ
ATTIVA
PRO



Stimolazione Sensoriale Lato Plegico

Mantenere consapevolezza corporea · 5 min · quotidiano



OBIETTIVO:

Prevenire negligenza spaziale (neglect)



MATERIALI:

Panno, spazzola morbida, oggetto ruvido



WARNING:

Fermare al primo segno di dolore o instabilità.

ESECUZIONE

- 1 Caregiver o paziente stesso con lato sano.
- 2 Passare panno morbido sul lato plegico dalla spalla alla mano lentamente.
- 3 Ripetere con spazzola.
- 4 Ripetere con oggetto ruvido.
- 5 Nominare la parte toccata.
- 6 5 min quotidiano.



Panno morbido



Spazzola morbida



Oggetto ruvido



TERZA ETÀ
ATTIVA PRO

Controllo Tronco per Lato Plegico

Rinforzo tronco per stabilità · 2×5 · seduta



OBIETTIVO:

Rinforzo tronco per stabilità posturale



MATERIALI:

Sedia stabile con schienale



WARNING:

Fermare al primo segno di dolore o instabilità

ESECUZIONE

- 1 Seduto con schiena appoggiata.
- 2 Lato sano su fianco.
- 3 Cercare di inclinare tronco verso lato plegico.
- 4 Tornare centro.
- 5 5×.
- 6 2 serie.



Posizionamento a Letto per Emiparesi

Posizionamento antispastico · continuo · caregiver



OBIETTIVO:

Prevenire posture antalgiche e spastiche



MATERIALI:

Cuscini modellabili



PROCEDURA



1. In decubito sul lato sano:

- 1) Braccio plegico esteso in avanti su cuscino;
- 2) Gamba plegica flessa su cuscino tra le ginocchia;
- 3) Tronco ben allineato;
4. Cambio posizione ogni 2-3h.



2. In decubito supino:

- 1) Cuscino sotto scapola lato plegico;
- 5) 2) Braccio esteso e supinato;
- 6) 3) Cuscino sotto anca per evitare rotazione esterna.



ATTENZIONE: Coinvolgere caregiver formato — posizionamento errato peggiora spasticità



WARNING · BONUS 1 · MOBILITÀ RIDOTTA

Spasticità · Quando Preoccuparsi



Riconoscere spasticità patologica



Iper tono normale post-ictus:

aumenta con sforzo/emozione,
non impedisce movimento passivo.



Spasticità patologica:

resistenza costante al movimento passivo,
causa dolore, limita l'articolarietà,
causa contratture.



Se osservata:

valutazione neurologica per considerare
trattamenti (fisioterapia intensiva,
tossina botulinica, farmaci).



REGOLA D'ORO:

*Non massaggiare mai un muscolo
spastico contro resistenza*



Stimolazione nella Fase Precoce Post-Ictus

Attivazione fase subacuta (settimane 1-4) · continuo · équipe



OBIETTIVO:

Massimizzare recupero nella finestra di plasticità



MATERIALI:

Équipe multidisciplinare

PROCEDURA

- 1 Principi:** 1) Iniziare entro 48h da stabilizzazione clinica
- 2 Ripetizione elevata:** 300+ ripetizioni giorno per movimento target
- 3 Task-oriented:** esercizi legati a compiti reali (afferrare bicchiere, portarlo alla bocca)
- 4 Coinvolgere lato plegico** anche se debolissimo (constraint-induced therapy)
- 5 Aumento graduale** complessità
- 6 Sinergia** con logopedista + terapeuta occupazionale
- 7 Coinvolgere famiglia** in continuità



ATTENZIONE:

La finestra 3-6 mesi post-ictus è la più preziosa — non perderla

Come Adattare Ogni Esercizio a Mobilità Ridotta



Formula universale di adattamento · sempre



OBIETTIVO:

Trasformare qualunque esercizio del kit in versione mobilità-ridotta



MATERIALI:

Nessuno



PROCEDURA

- 1 **Formula 3D: DURATA** ridurre a metà (20 sec invece di 40)
- 2 **DENSITÀ** ridurre ripetizioni a 30% (3 invece di 10)
- 3 **DIMENSIONE** ridurre range articolare a 40-60%.
- 4 Sostituire ogni esercizio in piedi con versione **in car**.
- 5 Eliminare salti, balzi e movimenti rapidi.
- 6 Aumentare i tempi di recupero tra gli esercizi (30-60 sec).
- 7 Monitorare sempre affaticamento e respiro. Comfort prima della performance.



ATTENZIONE:

Se il paziente si stanca al 3° esercizio, sospendere e riprendere il giorno dopo con carico ridotto



Gestire la Fatica Neurologica

La fatica cronica in pazienti neurologici · sempre



OBIETTIVO:

Riconoscere e gestire la fatica non muscolare tipica di sclerosi/ictus/Parkinson



MATERIALI:

Diario fatica



PROCEDURA:

1

La fatica neurologica non si stanca “dopo lo sforzo”: è presente sempre, aumenta a fine giornata, pe;

2

Sedute più brevi ma quotidiane (20 min × 5) meglio che 90 min × 2;

3

Pause obbligatorie ogni 5 min;

4

Monitoraggio soggettivo con scala 0-10;

5

Se fatica >6/10 sospendere.



ATTENZIONE:

Fermare al primo segno di dolore o instabilità

Attrezzatura Minima per Mobilità Ridotta

Setup essenziale per lavorare con questi pazienti • una tantum



OBIETTIVO: Kit minimo per casa/RSA



MATERIALI: Materiali



1 Cintura ergonomica per trasferimenti

Facilita trasferimenti sicuri e riduce il carico sull'operatore.



2 Cuscini modellabili (min 4)

Supporto e posizionamento personalizzato per comfort e prevenzione piaghe da decubito.



3 Poggipiedi carrozzina regolabile

Regolabile in altezza e inclinazione per comfort e postura corretta.



4 Bastone lungo (per esercizi bimanuali)

Utile per mobilizzazioni assistite e esercizi coordinativi.



5 Palla morbida senior

Leggera e soffice, ideale per esercizi di mobilità e stimolazione.



6 Banda elastica leggera

Resistenza leggera per esercizi di mobilizzazione e rinforzo muscolare.



7 Materassino antiscivolo

Superficie stabile e sicura per esercizi a terra e prevenzione scivolamenti.



8 Sfigmomanometro

Per monitorare la pressione arteriosa in sicurezza.



9 Saturimetro

Per il controllo della saturazione di ossigeno.



10 Termometro

Per la misurazione della temperatura corporea.



COSTO TOTALE STIMATO
~150-200€

Stima indicativa dei costi per l'acquisto di attrezzatura essenziale di base.
I prezzi possono variare in base al fornitore e alla qualità dei prodotti.



WARNING: Fermare al primo segno di dolore o instabilità

Comunicare con il Caregiver Familiare

Formare e coinvolgere chi accudisce · continuo



OBIETTIVO:

Il caregiver è il moltiplicatore del lavoro terapeutico



MATERIALI:

Kit di formazione



PROCEDURA:

- 1 Prima seduta con caregiver presente (osserva).
- 2 Seconda seduta: caregiver fa 1 esercizio sotto supervisione.
- 3 Consegnare 4 esercizi 'da caregiver' scritti su A4 max.
- 4 Chiedere 3 volte a settimana.
- 5 Verificare esecuzione settimana successiva.
- 6 Riconoscere il carico emotivo del caregiver ('è dura anche per te').
- 7 Segnalare al servizio sociale se caregiver in burnout.



ATTENZIONE:

Fermare al primo segno di dolore o instabilità



Valutare la Motivazione del Paziente

Screening di adesione al programma • prima seduta



OBIETTIVO:
Massimizzare compliance



MATERIALI:
Colloquio

5 DOMANDE CHIAVE

- 1 Cosa vorresti riuscire a fare che oggi non riesci?
(obiettivo funzionale)
- 2 Da 1 a 10 quanto è importante per te?
(motivazione)
- 3 Da 1 a 10 quanto ti senti in grado di riuscirci?
(autoefficacia)
- 4 Cosa potrebbe fermarti?
(ostacoli)
- 5 Cosa ti aiuterebbe?
(risorse)



Se motivazione <5
lavorare prima sul senso,
non sull'esercizio.



⚠ WARNING:
Un paziente demotivato non fa esercizi
anche se prescritti — non insistere sul cosa,
chiarire il perché.



WARNING · BONUS 1 · MOBILITÀ RIDOTTA

Controindicazioni alla Mobilizzazione Passiva

Quando NON mobilizzare · sempre



STOP mobilizzazione passiva se:

- 1 Frattura recente non stabilizzata ·
- 2 Chirurgia ortopedica <2 settimane
- 3 Trombosi venosa acuta ·
- 4 Ossificazione eterotopica in fase attiva
(*calor+rubor+dolor*)
- 5 Dolore acuto durante il movimento ·
- 6 Segni infiammatori acuti sull'articolazione ·
- 7 Instabilità emodinamica

Consultare medico/fisioterapista prima di riprendere.



REGOLA D'ORO:

*Non è compito del caregiver decidere
quando riprendere — solo del professionista*



Glossario Mobilità Ridotta



Piaghe da decubito:

lesioni cutanee da pressione prolungata



Ipotensione ortostatica:

caduta di pressione all'alzarsi



Neglect:

negligenza spaziale post-ictus



Sarcopenia:

perdita di massa muscolare età-correlata



Spasticità:

aumento resistenza al movimento passivo



Cintura ergonomica:

dispositivo di sicurezza per trasferimenti



TVP:

Trombosi Venosa Profonda



Deambulatore:

ausilio con appoggi bilaterali



Ortostatismo:

passaggio a posizione eretta



Costellazione:

dinamica sistema familiare



BONUS 1 • pagina 39





TERZA ETÀ ATTIVA PRO

MOVIMENTO • SALUTE • AUTONOMIA

GRAZIE

Hai finito il Bonus 1.

Ora torna al Kit principale
(Terza Età Attiva Pro) e integra
questi 100 esercizi nei tuoi programmi.

La sicurezza prima di tutto.

PROSSIMI PASSI

- 1 Torna al Kit principale
- 2 Consulta il Bonus 3
(Guida di Valutazione) per misurare
i progressi
- 3 Documenta ogni seduta

